جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : امل فرج عبدالعزيز فرج

المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** اخري **العنوان :** قريه الاخصاص منشاه القناطر

رقم البطاقة : 27309192100685 **رقم التليفون :** 01017453264 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 19-09-1973 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**

التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة [11129] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------

خطة العلاج : ----------

المستشفي : ----------**قسم :** ----------

جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------

ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: امل فرج عبدالعزيز فرج
National ID: 27309192100685

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

٢٠٢٦/١٠/١١

جوستاف روسي انترناشونال مصر

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

الست المصرية هي صحة مصر

MDT FORM / / 20 G

Name	[illegible]	MRN	
		ID	
Age		Phone	٠١٠١٧٥٢٥٢٦٢
Menopausal status		Marital status	
NRS SCORE		Family history	
BMI		REASON OF MDT	new
CO morbidity			

Clinical Data

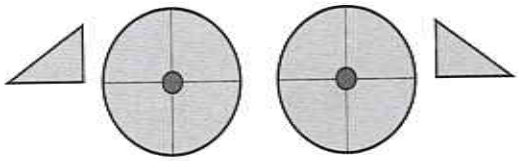
BX: IDC G II

ER:	PR:	HER 2:	Ki67:
+/+	+/-	0	60%

Sonomammography: ACRC Rt breast mass

Mets Workup: CEST is recommended

R L



T N M

Recommendations:

MDT OUTCOME & PLAN

for CEST

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]



National ID – Front
[[DOCTYPE:ID_FRONT]]


٢٧٣٠٩١٩٢١٠٠٦٨٥
٢٠٢٥/٠٩
ربة منزل
انثى مسلمة متزوجة
احمد ابو العنين مبروك عبدالله
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٩/١١
١

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL

Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي انترناشونال – مصر معمل الباثولوجي

جوستاف روسي

Patient Name	امل فرج عبد العزيز	**Case No.**	**361728**
Sex/Age	**Female 53 Y**	**Patient No.**	**26539**
Registered Date	**31/8/2026 03:21:40 PM**	**Referred By Dr.**	**Interventional Radiology**
Validation Date	**07/10/2026 10:37:00 AM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**07/10/2026 10:40:12 AM**	**Pathology No.**	**2800/26**

Pathology Report (Corrected report)

Clinical Data: Right breast mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 31/08/2026, Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:
- Five grayish white tissue cores, ranging in length between 1 cm & 2 cm, totally submitted.

Technique:
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench-Mark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:
- **Histologic type:** Invasive duct carcinoma.
- **Histologic grade:** 3 (differentiation 3, pleomorphism 3, mitosis 2).
- **Ductal carcinoma in situ:** Absent.
- **Microcalcification:** Absent.
- **Angioinvasion:** Absent.
- **Perineural invasion:** Absent.
- **Tumor infiltrating lymphocytes (TILs):** Moderate.

Results:

*** IPT (All controls showed appropriate reactivity):**
- ER: Strong nuclear reaction in 98% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 35% of tumor cells (score 7/8).
- Her2: No membrane reaction in tumor cells (score 0).
- Ki67%: 60%.

[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]
Pathology Report

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL
Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي انترناشونال – مصر معمل الباثولوجي
جوستاف روسي

Patient Name	**امل فرج عبد العزيز**	**Case No.**	**361728**
Sex/Age	**Female 53 Y**	**Patient No.**	**26539**
Registered Date	**31/8/2026 03:21:40 PM**	**Referred By Dr.**	**Interventional Radiology**
Validation Date	**07/10/2026 10:37:00 AM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**07/10/2026 10:40:12 AM**	**Pathology No.**	**2800/26**

Conclusion:
Right breast mass, Tru-cut biopsy:
- Invasive duct carcinoma, Grade 3.
IPT:
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 7/8).
- Her2: Negative (score 0).
- Ki67%: 60%.
N.B; This report was corrected upon receiving new data that the lesion is in the (Right breast side) & not the (left one).

***Scoring system: "ER, PR"*
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
*** Scoring system: "Her2"*
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.
IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of
the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]
Mammogram

اسم المريض بالإنجليزية: Amal Farag Abdalaziz Farag	كود المريض: 98726
تاريخ التقرير: 2026/08/25 01:33:04 PM	السن: ٥٢ سنة, ١١ شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: right breast lump.

Left breast:

- Heterogeneously dense breast (ACR density c).
- The Left breast shows UOQ , posterior third oval circumscribed density , likely IMLN , with no definite correlate BY us
- Upper midline, posterior third focal asymmetry with no underlying abnormalities as confirmed by Tomosynthesis and US.
- **Ultrasound** revealed scattered small clear cysts.
- Normal nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Right breast:

- Heterogeneously dense breast (ACR density c).
- LOQ deeply seated irregular ill-defined bi-lobar mass lesion with long spicules showing calcifications.
- **Ultrasound** demonstrated 7 o'clock, zone c irregular ill-defined mass hypoechoic mass lesion, measures 25 x 14 mm, 2 mm from overlying skin , with mild color uptake on Doppler study .
- UOQ , middle zone grouped small clear cysts
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Enlarged level I axillary LNs, all show preserved hilum , ONE measures 15 x 10 mm , SHOW diffuse cortical thickening measures 4 mm (indeterminate).

Impression:

- **Right breast (BIRADS 5): 7 o'clock malignant mass lesion as described with ipsilateral indeterminate level I axillary lymph node . for sonar guided biopsy**
- **Left breast (BIRADS 3): Upper midline focal asymmetry, for close US follow up . CESM study is recommended.**

Much obliged,

Dr. RANIA AHMED , MD



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

امل
فرج عبدالعزيز فرج
قرية الاخصاص
منشاة القناطر - الجيزه

١٩٧٣/٠٩

٢٧٣ ٠٩ ١٩ ٢١ ٠٠٦ ٨٥

LJ2159858

٠١٠١٧٤٥٢٤٦٤

٢٧٣٠٩١٩٢١٠٠٦٨٥ ٢٠٢٥/٠٩

ربة منزل

أنثى مسلمة متزوجة

احمد ابوالعنين مبروك عبدالله

١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٩/١١

National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية للنظم المعلومات و التحول
الرقمى

رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار :25-8-2026

جهه الاصدار :فرع الجيزة

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطيقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) امل فرج عبدالعزيز فرج بطاقة رقم 27309192100685

تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الأنتفاع

يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل

وشكرا

تاريخ الطباعه :25-8-2026

الهيئة العامة للتأمين الصحى
الموظف المختص
إدارة [illegible] كريمه ابراهيم
قسم المعلومات

افادة مركز نظم المعلومات

يعتمد

مسلسل 2060122

الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار [illegible] قبل الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزراة التربية و التعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى

Non-UHIA Letter.
[[DOCTYPE:NON_UHIA_LETTER]]

اسم المريض بالإنجليزية: Amal Farag Abdalaziz Farag	كود المريض: 98726
تاريخ التقرير: 2026/08/25 01:33:04 PM	السن: ٥٢ سنة, ١١ شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: right breast lump.

Left breast:

- Heterogeneously dense breast (ACR density c).
- The Left breast shows UOQ , posterior third oval circumscribed density , likely IMLN , with no definite correlate BY us
- Upper midline, posterior third focal asymmetry with no underlying abnormalities as confirmed by Tomosynthesis and US.
- **Ultrasound** revealed scattered small clear cysts.
- Normal nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Right breast:

- Heterogeneously dense breast (ACR density c).
- LOQ deeply seated irregular ill-defined bi-lobar mass lesion with long spicules showing calcifications.
- **Ultrasound** demonstrated 7 o'clock, zone c irregular ill-defined mass hypoechoic mass lesion, measures 25 x 14 mm, 2 mm from overlying skin , with mild color uptake on Doppler study .
- UOQ , middle zone grouped small clear cysts
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Enlarged level I axillary LNs, all show preserved hilum , ONE measures 15 x 10 mm , SHOW diffuse cortical thickening measures 4 mm (indeterminate).

Impression:

- **Right breast (BIRADS 5): 7 o'clock malignant mass lesion as described with ipsilateral indeterminate level I axillary lymph node . for sonar guided biopsy**
- **Left breast (BIRADS 3): Upper midline focal asymmetry, for close US follow up . CESM study is recommended.**

Much obliged,

Dr. RANIA AHMED , MD

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]